

إذا كنت تفكرين في إجراء جراحة لعلاج هبوط أعضاء الحوض، فثمة عدة خيارات تناقشينها مع جراحك. لا توجد إجابة واحدة صحيحة في الغالب — تعتمد الخطة المثلى على تشريح جسمك وصحتك وما يهّمك أكثر. تستعرض هذه النشرة القرارات الرئيسية لتتمكني من إجراء محادثة مستنيرة.

القرارات الرئيسية

- **الإصلاح أم الإغلاق** — إعادة بناء الدعم (إصلاح إعادة بنائي) وإبقاء المهبل مفتوحاً، أو إغلاق المهبل (colpocleisis) إن لم تكوني تخططين للجماع المهبل.
- **المسار الجراحي** — عبر المهبل، أو عبر البطن بالجراحة المنظارية/الروبوتية.
- **الرحم** — استئصاله (استئصال الرحم) أو الإبقاء عليه بتعليق يحافظ على الرحم (hysteropexy).
- **مادة الدعم** — أنسجتك الذاتية (إصلاح بالأنسجة الطبيعية)، أو طعم بيولوجي، أو شبكة اصطناعية (mesh) كتلك المستخدمة في sacrocolpopexy البطني.
- **تسرّب البول** — هل تُضيفين إجراءً لمنع التسرّب الآن (انظري أدناه).

تسرّب مخفي

أحياناً يُخفي هبوط الحوض الكبير سلس بول إجهادياً يظهر فقط بعد إصلاح الهبوط ("occult SUI"). قد يختبر الفريق الطبي هذا الاحتمال ويناقشاً معك إضافة حبال (sling) في نفس الوقت أو الانتظار.

تعلم المصطلحات

إعادة بنائي (Reconstructive)

إعادة بناء الدعم مع الحفاظ على وظيفة المهبل.

إغلاق (Obliterative)

إغلاق المهبل (colpocleisis) — متين جداً، ينهي الجماع.

Hysteropexy

تعليق يحافظ على الرحم دون استئصاله.

إصلاح بالأنسجة الذاتية

إصلاح باستخدام أنسجتك الخاصة دون طعم.

Occult SUI

سلس بول إجهادي مخفي يظهر بعد إصلاح الهبوط.

التكرار (Recurrence)

احتمال عودة هبوط الأعضاء مع مرور الوقت.

كيف أختار؟ بمطابقة الخيارات مع أولوياتك — المتانة، وقت التعافي، الحفاظ على الرحم، النشاط الجنسي، وموقفك من الشبكة الاصطناعية. سيوصي جراحك بما يناسب تشريحك وصحتك؛ والخيار "الأفضل" هو الذي يتوافق مع أهدافك بعد نقاش واضح.

أسئلة تطرحها على جراحك

- أي إجراء (أو إجراءات) توصي به لي ولماذا؟
- مسار مهبلي أم بطني — وكيف يبدو التعافي في كل منهما؟
- هل يمكنني (أو ينبغي لي) الحفاظ على رحمي؟
- هل ستستخدم أنسجتي الذاتية أم طعماً أم شبكة اصطناعية — وما المخاطر؟
- هل أحتاج إجراء لمنع التسرب الآن أم لاحقاً؟
- ما احتمالية التكرار، وماذا إن عاد الهبوط؟

ما يستحق المعرفة أيضاً

- الفرزجة (pessary) بديل غير جراحي دائماً إن أردت تجنب الجراحة أو تأجيلها.
- تحسين الوزن، والإمساك، والسعال، واستخدام الإستروجين المهبلي (بعد سن اليأس) يحسّن النتائج.

كيف تستعدين

- أكمل الفحوصات قبل الجراحة واحضري قائمة كاملة بأدويةك.
- اعزمي على الإقلاع عن التدخين ورتبي مساعدة في المنزل.
- تذكري القاعدة العامة للتعافي: تجنبي الرفع الثقيل والجماع نحو 6 أسابيع.

أخبري فريقك الطبي قبل الجراحة إذا كنت:

- تتناولين مميعاً للدم أو لديك مشكلة في النزيف
- تعانين من عدوى بولية أو مهبلية حالياً
- تشعرين بألم حوضي جديد، أو نزيف، أو قرحة لا تلتئم على منطقة الهبوط

ثلاثة أمور تذكّرها

1. تتضمن جراحة هبوط الأعضاء عدة خيارات — الإصلاح أو الإغلاق، المسار، الحفاظ على الرحم، مادة الدعم، وعلاج التسرب المخفي.
2. نادراً ما توجد إجابة واحدة صحيحة؛ الخطة المثلى تتوافق مع تشريحك وأولوياتك.
3. اطرحي الأسئلة الجوهرية، وتذكري أن الفرزجة (pessary) بديل غير جراحي دائماً.